جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : ماجده طايل عدلان طايل
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** بولاق الدكرور **العنوان :** =
رقم البطاقة : 29208072100742 **رقم التليفون :** 01094481272 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 15-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 07-08-1992 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: ماجده طايل عدلان طايل
National ID: 29208072100742

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Bilateral mammogram and breast ultrasound**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

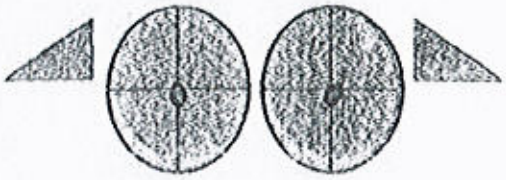




National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

MDT FORM

Name	[illegible]
Age	28
MRN	٤٩٤٠٨٠٧٤١٠٧٤٤
ID	١٤٨٥٤٠٩١٤
Co morbidity	١٥٠٤ ٤٠٤١



pt was pregnant at 2nd [illegible]

Rt breast cancer

Clinical Data

now she gave birth (9/10/2021)

Bx: c T2 N0 M - Pds → T1b N1(3/4)	SM:
IHC: ER: → 8/8 (+ve) PR: → 2/8 (+ve) HerY: 1+ve → (-ve) KHV: 3+/3	Mets Workup:
T N M	
COMMENT: pt received 3 cycles of TAC last one (26/7/2021) then she gave birth. (9/10/2021)	

MDT OUTCOME & PLAN

Review of data:

- PORT to Rt. breast & SC
- Adjuvant Zoladex + AI + Prolia

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
، هرمل ، سابقا

12-4-2021

Name : [illegible]
Age : 28 y
No.:

MDT FORM

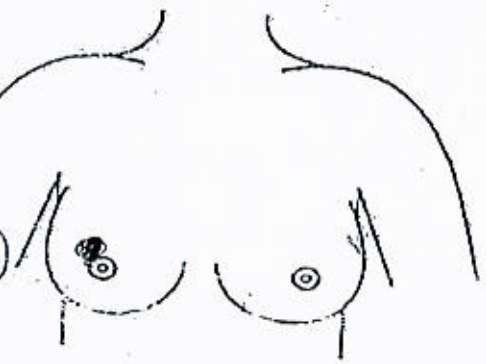
Clinical data : Pregnant 16 weeks

Right Br Ca

cT2 No M

BCS. T1b N1 (3/12)

(Ch. Rad: 1 cm x 0.5 cm)



ER 8/8 PR 7/8 HER2-ve Ki67 = 30%

Reason of discussion:

New Breast U/S to assess tumor extension + skin mark x
- Abd U/S CXR (with shield)

MDT Outcome and Plan

for BCS + Axillary level I dissection
BCS done → for adjuvant chemo
Taxotere x4 → AC x4

Signature :

C.C/7/21

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

مستشفى أورام دار السلام
قسم الباثولوجى

Pathology Report

Name: ماجده طايل عدلان طايل Ag 30:years.

Clinical data: Breast cancer.

Specimen type :Wide local excision, extra margins and axillary LNs.

Date (Received):27 /4/2021 Date(reported): 22/5/2021

Lab. Number: 920/21 Hospital Number:

Gross Description:

Four specimens were received and submitted as:

1)WLE, measure 5x3x2cm, covering skin 5x3cm, cut sections revealed a retro areolar mass measure 0.5x0.5 cm, another mass measure 1x1x1 cm, away from the retro areolar mass by 2 cm , the least deep margin 1.5 and (1.5,2,2,1) superior, inferior, media', lateral margins respectively.

2)level I lymph nodes contain 5L.N up to 1x1 cm.

3) Extra inferior margin: fatty tissue measure 2x1x0.5.

4)Lateral, deep and inferior margins: fatty tissue measure 2x2x1 cm.

5) Axillary LNs: fatty tissue 3x3x1cm, entangling 12 L.N up to 1.5cm in diameter.

Microscopic Examination:

histopathological examination of sections prepared from the tumour masses reveals an infiltrating malignant epithelial growth made up of groups and sheets of pleomorphic hyperchromatic malignant ductal epithelial cells. Stromal desmoplasia is moderate. Cellular and nuclear atypia are moderate [grade II]. A residual intraduct component (10%) could be detected. The tumor infiltrate the base of the nipple and areola but not reaching the skin. Three lymph nodes out of 12 LN detected show metastatic deposits [Nodal score is 3/12 = N1] with extracapsular extension. surgical margins are free

Diagnosis:

Breast mass,Wide local excision, extra margins and axillary LNs;

- **Bifocal Invasive duct carcinoma grade**
- **Positive Lymphatic emboli.**
- **No perineural infiltration**
- **10% insitu component.**
- **Tumor infiltrate the base of nipple but not reaching the skin.**
- **Free margins.**
- **LN 3/12 N1 with extracapsular extension.**
- **Free of tuomar tissue.**
- **Free skin of nipple.**

Prof. Dr. Amal Hareedy.
Dr. Mona Mohamed.

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name : Magda Tayeel Adlan Tayeel
Branch : Dokki
Ref.Physician Prof : Gostaf Roseh Hospital

Date : 20-10-2025 10:52
Medical No. : 229382
Ins.Company : تعاقد مستشفيات

$Tc^{99}m$ MDPSKELETAL SCINTIGRAPHY

History

- A 33-year-old lady, with history of right breast cancer and referred for metastatic workup.

Technique

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of the tracer.

Findings

- No abnormal active or cold focal bony lesions that could account for metastatic bone disease.
- Degenerative changes are noted at the spine and big joints.

Impression:

- The skeleton is free from metastases.

Best regards,
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

Patient Name: Magda Tail Adlan Tail	Date : 29/10/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 33 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 23333

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: Post Right CBS and ALAND followed by radiotherapy, routine follow up study.

Findings:

Right breast.

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b)
- UOQ, architectural distortion with no speculations, masses, asymmetry , or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated UOQ area of parenchymal disruption underneath the operative scar with no solid , cystic lesions or fluid collections.
- Normal nipple/areola complex.
- Clear right axilla. No pathological infra or supra-clavicular lymph nodes

Left breast.

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses asymmetry , distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion:-

Right breast (BIRADS 2): Post-therapeutic sequalae.
Left breast (BIRADS 1): Normal study.

Recommendation:-

For annual follow up.

Best Regards,
DR, RANIA AHMED , MD

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـــان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Magda Tail Adlan Tail	Date : 21/11/2024
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 32 Year(s)
Medical ID: 5454/2021	Pat. ID: 23333

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Patient had right CBS

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- right breast areolar focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- Complementary ultrasound showed right breast areolar and UOQ focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with clear operative bed with no evidence of recurrent mass lesions.
- no left breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Nonspecific left axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free right infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Right breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions (BIRADS 2)
- Normal study of the left breast (BIRADS 1)

Yours truly

Signature Dr. Engy Abdallah

21/11/2024 12:55 PM

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Women s Health Outreach Program

Name: Magda tayel adl n

Date: Wednesday, Dece ber 23, 2020

Bilateral onomammography

Clinical presention:right reolar 9 oclcock lump , of 1 yer duration increased in size lately

Ultrasound Findings:

- Bilateral homoge neous gla ndular echotexture.
- Right breast at o'clock areolar skin oval well circumscribed hyooechoic mas 8x4 mm underneath which is a small rounded irregular mass n easuring ox5 mm .
- No left solid or ystic mas s.
- No susicious a: illary lym ph node ,

Conclusion:

- Right breast ar olar an retraoreolar small mass as foredtailed **BIRADS 4A** fo r iopsy an histopthology .
- Left unremarka ble study **BIRADS1.**

Best regards,

Dr. Nivine Chalabi,MD

٣٠٥٣ ش كورنيش النيل . فم الخليج .القاهرة. جمهورية مصر العربية
ت/ف : ٠٢٢٣٦٤٥٨١٣
بريد الإلكتروني:info@whop.gov.eg
الموقع الالكتروني www.whop.gov.eg

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]



DMS
ضيمار ١ أوفاركس
لتدعيم



National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]